二氢吡啶类CCB主要扩动脉

3.高血压亚急症：口服快速起效降压药如 CCB，24-48 小时内降压

VS 非二氢吡啶类CCB主要针对心脏

四、治疗

（一）降压目标

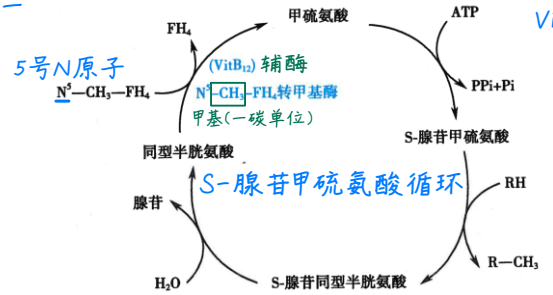
一般	**＜140/90**
围术期术前准备	高血压**继续服用**降压药避免戒断综合征，**BP≤140/90**
合并**糖尿病、肾病、心衰、冠心病**	**＜130/80**（糖肾心心小三八）
肾衰竭章节	慢性肾衰竭：＜130/80（若尿白蛋白/肌酐＜30 或透析＜140/90）
原发性肾小球疾病章节	慢性肾小球肾炎：收缩压＜120、尿蛋白＜1
老年人单纯收缩期高血压 （动脉粥样硬化致弹性储器作用↓）	强调收缩压达标 无合并症时＜**150/90（特别＞80 岁）**，若可耐受＜140/90 有合并症按小三八
高血压急症	2-6 小时内血压降至 **160/100** 安全水平

（二）一般治疗

①限钠＜6g/d。不同地区血压水平与钠摄入量呈正相关、摄入量过多导致血压升高见于**盐敏感**人群

②补钾，补**叶酸**（降同型半胱氨酸）甲基(一个碳原子的有机基团):属于一碳单位,不能游离存在,需要载体(FH4)

钾与血压负相关　危险因素之一



VitB12↓→ N5-CH3-FH4转甲基酶×

↓

FH4相对缺乏

↓

不能载其他一碳单位

↓

核苷酸合成障碍→巨幼贫

当VitB12缺乏时,只给叶酸没有意义,要给够VitB12

（三）降压药

①保护靶器官②一次给药就可控制夜间和晨峰血压

1.用药原则：①个体化用药，②小剂量开始，③优先选择长效制剂，④联合用药（若三种降压药联合必须包含**利尿剂**），⑤降压时应尽早达标、但并非越快越好，⑥不能随意停药或频繁改变治疗方案

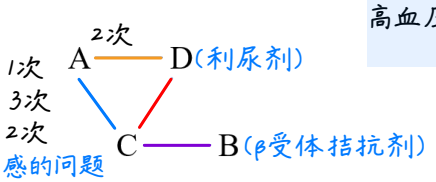
高血压特点是盐敏感,利尿剂排钠利尿　避免反跳现象

高血压不严重→1种
高血压有点严重→2种
→3种(必须要有利尿剂)

2.优化联合治疗方案

拮抗RAAS扩血管

一线用药（ABCD）
- ACEI/ARB/ARNI
- β-R拮抗剂
- CCB(可以排钠利尿)
- 利尿剂



利尿剂和CCB都可以排钠利尿解决盐敏感的问题
CCB和ACEI/ARB/ARNI都可以解决细小动脉痉挛的问题

联合治疗应采用不同降压机制的药物，我国临床主要推荐应用优化联合治疗方案是：①ACEI/ARB+二氢吡啶类 CCB；②ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂；③二氢吡啶类 CCB+噻嗪类利尿剂；④二氢吡啶类 CCB+β 受体拮抗剂。次要推荐使用的联合治疗方案是：利尿剂+β 受体拮抗剂；α 体受体拮抗剂+β 受体拮抗剂；二氢吡啶类 CCB+保钾利尿剂；噻嗪类利尿剂+保钾利尿剂。

联合治疗也可以选择单片固定复方制剂（SPC），通常由不同作用机制的两种或两种以上的降压药组成，与自由联合的降压治疗相比，SPC 使用方便，可改善治疗的依从性及疗效。目前常用的 SPC 包括 ACEI/ARB+二氢吡啶类 CCB；ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂和二氢吡啶类 CCB+β 受体拮抗剂。三种降压药联合治疗一般应包含利尿剂。采用合理的治疗方案和良好的治疗依从性，一般可使病人在 4～12 周内达到血压控制目标值。

病理:高血压→细小动脉痉挛→细小动脉玻璃样变性
只有ACEI/ARB和二氢吡啶类CCB才能针对细小动脉